# 편두통 — 위장 증상에 가려진 진짜 원인

메스꺼움·소화불량과 함께 오는 두통은 단순히 "체한 것"이 아닐 수 있습니다. 편두통 환자의 60~90%가 메스꺼움·구토 같은 위장 증상을 함께 겪습니다. 집에서는 두통일기와 규칙적인 생활이 치료의 기본입니다.

### 위장 증상으로 먼저 오는 편두통

두통 하루이틀 전의 메스꺼움·식욕 변화, 발작 중 위가 느려져 **먹은 약이 잘 안 듣는 것**, 두통 없이 반복되는 복통·구토도 편두통의 한 모습일 수 있습니다. 내시경·복부 검사가 정상인데 이런 증상이 발작처럼 되풀이되면 진료 때 말씀해 주세요. 편두통은 4~72시간 이어지는 두통이 ①한쪽 ②욱신거림 ③중간 이상 세기 ④움직이면 심해짐 중 두 가지 이상이고, 메스꺼움·구토나 빛·소리 과민이 함께 오는 발작이 5번 이상 되풀이될 때 진단합니다.

## 두통일기 — 적어서 다음 진료 때 가져오세요



두통이 올 때마다 바로 적기

| 적을 것 | 예시 |
|---|---|
| **날짜·시각** | 시작한 때와 끝난 때 |
| **강도** | 0(없음)~10(가장 심함) 중 몇 점인지 |
| **유발 요인** | 잠 부족·늦잠, 끼니 거름, 생리, 스트레스, 술·음식, 날씨 |
| **먹은 약** | 약 이름·먹은 시각·효과가 있었는지 |
| **함께 온 증상** | 메스꺼움·구토, 빛·소리가 거슬림, 체한 느낌 |

## 오늘부터 실천할 7가지

| 생활 습관 | 약 먹는 법 · 운동 |
|---|---|
| ① **두통일기** 쓰기 — 날짜·강도·유발 요인·먹은 약 | ⑤ **발작이 시작되면 처방받은 약을 바로** — 참다 먹으면 효과가 떨어집니다 |
| ② **매일 같은 시각**에 자고 일어나기 (주말 포함) | ⑥ **진통제는 한 달에 10일 이하** — 약물 과용 두통 예방 |
| ③ **끼니 거르지 않기** · 물 충분히 마시기 | ⑦ **걷기 같은 유산소 운동**을 꾸준히 · 명상·요가 |
| ④ **카페인은 일정하게** — 갑자기 늘리거나 끊지 않기 | 메스꺼움이 심하면 **구토를 줄이는 약(진토제)**을 함께 처방받을 수 있습니다 |

**두통약을 한 달에 10일 넘게** 먹으면 두통이 더 잦아지는 **'약물 과용 두통'**이 올 수 있습니다.
발작이 한 달 4번 이상이거나 일상이 힘들면 **예방약**을 상담하세요.

### 이런 두통은 즉시 응급실 또는 정밀검사

- **벼락 두통** — 몇 초 만에 극심해짐 · **50세 이후 처음** 시작된 두통 · **열·목 뻣뻣함**이 함께 옴
- **한쪽 마비·말이 어눌함·시야가 가려짐** · 며칠~몇 주에 걸쳐 **점점 심해짐** · 기침·재채기에 심해짐

함께 보기 — 진료실에서 보신 설명 자료 「편두통 — 위장 증상에 가려진 진짜 원인」 edu.gwanggyobarun.com/decks/neurology/migraine/diagnosis/

박중철 강의: 한쪽 눈꺼풀 처짐과 복시는 후교통동맥 뇌동맥류가 제3뇌신경을 압박한 신호일 수 있습니다.
동공이 커지고 빛 반응이 둔한 눈꺼풀 처짐은 응급실 이송이 필요한 단서로 설명했습니다.
(아산28 · 검진에서 발견된 뇌동맥류: 어떻게 추적하고 언제 치료할까?(박중철))

성경림 강의: 갑작스러운 두통·안통·구토·시력 저하는 급성 폐쇄각녹내장의 증상일 수 있습니다.
(아산28 · 내과 의사가 알아야 할 녹내장 핵심 포인트(성경림))

약 복용·처치 후 갑작스러운 안통이나 시력 저하가 생기면 즉시 안과 진료를 받습니다.
(아산28 · 내과 의사가 알아야 할 녹내장 핵심 포인트(성경림))

Topiramate, 항콜린·교감신경 작용 약, 일부 항우울제·sulfa 약 등과 관련될 수 있습니다. 새로 시작한 약을 알려 주세요.
(아산28 · 내과 의사가 알아야 할 녹내장 핵심 포인트(성경림))

**광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine**
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · ☏ 031-893-4560
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 국제두통분류 3판(ICHD-3, 2018) · 대한두통학회 진료지침 (2021) · AHS Consensus Statement 2021

*본 자료는 일반 환자교육용입니다. 두통 양상이 변하거나 위험 신호가 나타나면 즉시 내원해 주세요.*

집에서 다시 보기
QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/neurology/migraine/